

1. Информация об индикаторе	
Цель	Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
Задача	Активизировать, при необходимости осуществление Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака во всех странах
Индикатор	Стандартизированная по возрасту распространенность употребления табака лицами в возрасте от 15 лет
2. Информация об организации	
Организация	Министерство здравоохранения Республики Казахстан
3. Определения и понятия	
Определение	Показатель определяется как процент населения в возрасте 15 лет и старше, который в настоящее время употребляет табак (курительный и/или некурительный табак) ежедневно или реже, чем ежедневно.
Основные понятия:	Потребление табака означает использование курительных и/или некурительных табачных изделий. «Нынешнее/текущее потребление» означает использование в настоящее время на момент опроса, будь то ежедневное или реже, чем ежедневное использование. Табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа и (или) других частей табачного растения в качестве сырья, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания, нюханья или иных способов потребления, в том числе с помощью системы для нагрева табака или любого иного прибора. «Курительные табачные изделия» включают сигареты промышленного производства, сигариллы, сигары, трубки, кальяны, собственноручно скрученный табак, кретек и любую другую форму табака, потребляемую путем курения. Изделия из нагреваемого табака - изделия, которые нагревают табачные стики, с выделением аэрозоля, содержащего никотин и другие химические вещества. Некурительные табачные (никотин-содержащие) изделия – продукты, содержащие никотин, полностью или частично изготовленные из табачного листа и (или) других частей табачного растения в качестве сырья и их синтетических аналогов, приготовленных таким образом, чтобы использовать для сосания, жевания, нюханья.
Обоснование и толкование	Использование табака является одним из основных факторов, способствующих болезни и смерти от неинфекционных заболеваний (НИЗ). Нет доказанного безопасного уровня употребления табака или побочного воздействия табачного дыма. Все ежедневные и не ежедневные пользователи табака подвержены риску множества плохих результатов в отношении здоровья на протяжении всего жизненного цикла, включая развитие НИЗ. Сокращение распространенности нынешнего употребления табака внесет большой вклад в снижение преждевременной смертности от НИЗ (задача 3.4).

	Текущий и регулярный мониторинг этого показателя необходим для точного мониторинга и оценки воздействия реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) или политики борьбы против табака. Уровни распространенности употребления табака являются надлежащим показателем реализации ЦУР задачи 3.а «Активизировать, при необходимости осуществление Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака во всех странах». Для определения прогресса в борьбе против табака на национальном уровне и выполнения обязательств страны по РКБТ ВОЗ, в Республике Казахстан Министерством здравоохранения в 2014 и в 2019 годах был проведен Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS). GATS это национальный репрезентативный опрос взрослого населения 15 лет и старше на основе глобальной стандартной методологии. Стандартизированные подходы к оценке и отчетности имеют важное значение для обеспечения сопоставимости результатов между странами, участвующими в Глобальном обследовании употребления табака среди взрослых (GATS).
4. Источники данных и методы сбора	
Источники данных	По результатам Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака, проведенного в 2019 годах, (GATS, Global adult tobacco survey).
Методы сбора данных	Целевая группа населения - домохозяйства РК, проживающие в них взрослые 15 лет и старше. Применялась трехступенчатая стратифицированная кластерная выборка для отбора респондентов. Первичными единицами выборки (ПЕВ) являлись населенные пункты согласно определению Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Общее число населённых пунктов, случайным образом отобранных для участия в опросе, составило 371. Структура населённых пунктов была стратифицирована, и был сформирован 31 слой, 28 из которых были определены как городские/сельские в 14 областях, и три дополнительных городских слоя для городов республиканского значения. На втором этапе вторичные единицы выборки (ВЕВ) представляли собой домохозяйства из национального жилищного реестра. В 371 населённом пункте было отобрано 11 501 домохозяйств. На третьем этапе проводился опрос выбранного домохозяйства, а также случайным образом осуществлялся выбор одного взрослого человека в каждом из этих домохозяйств. Для сбора данных использовались компактные электронные устройства (планшеты). 10 832 респондентов приняло участие в опросе, с откликом в 96,8%. Для опроса была адаптирована и применена стандартизированная анкета, содержавшая вопросы по социально-демографическим

	характеристикам, потреблению табачных изделий, отказам от потребления табака, пассивному курению, экономическим аспектам потребления табака, СМИ, знаниям, отношению и восприятию аспектов, касающихся табака. Опрос был проведен с 27 сентября по 9 декабря 2019 года в 14 областях и гг. Алматы, Нур-Султан (Астана) и Шымкент. Перед анализом данных были рассчитаны веса выборки для каждого респондента. Эти веса были разработаны в соответствии со стандартными процедурами, установленными в Руководстве по дизайну выборки GATS и Руководстве по весам выборки GATS. Определение весов выборки включало три этапа: 1. Определение базового веса, который был рассчитан на основе случайного отбора на всех этапах; 2. Была произведена корректировка для несобранных данных; и 3. В окончательные выборочные данные была внесена калибровочная корректировка после стратификации, чтобы отразить население Казахстана в возрасте 15 лет и старше в разбивке по месту жительства, полу и возрастной группе. Окончательные веса использовались во всех аналитических работах для оценки параметров населения и доверительных интервалов.
Единица измерения	Процент
Периодичность	Каждые 4-5 лет
5. Метод расчета и другие методологические соображения	
Метод расчета:	Числитель: Количество нынешних ежедневных и реже, чем ежедневных курильщиков табака и/или потребителей бездымного табака. Знаменатель: Общее число респондентов.
Комментарии и ограничения:	Данный показатель позволяет проводить сравнения в динамике и также межстрановые сравнения по распространенности потребления табака. Показатель является ключевым и рекомендован ВОЗ и CDC в составе набора основных вопросов по табаку для применения.
6. Доступность данных и дезагрегация	
Доступность данных и пробелы:	Данные за 2019 год, ссылка на Страновой отчет и краткие бюллетени: https://hls.kz/ru/publications-ru Данные доступны также на сайте ВОЗ: https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-6246-46011-66506
Уровень дезагрегации:	Дезагрегация по полу, возрастным группам 15-24 лет, 25-44 лет, 45-64 лет и 65 лет и старше, по местности проживания: город и село. по уровню образования: начальное, среднее, средне-техническое и высшее.
7. Сопоставимость с международными данными / стандартами	Данные сопоставимы с международными данными

8. Ссылки и документация	Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака. Республика Казахстан, 2019 г. Страновой отчет. https://hls.kz/ru/publications-ru Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака, сравнительный информационный бюллетень 2014 и 2019 гг. https://hls.kz/ru/publications-ru Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака, информационный бюллетень 2019 гг. https://hls.kz/ru/publications-ru Global Adult Tobacco Survey in Kazakhstan, 2019. National report https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-6246-46011-66506 Global Adult Tobacco Survey in Kazakhstan, 2019. Fact sheet. https://hls.kz/uploads/scientific-facts/eng/GATS-KAZ-2019_FS_ENG_23NOV2020.pdf
---------------------------------	--